

시험 관견 코멘트



복통의 경우 급성/만성 통증으로 구분 후 통증을 호소하는 부위에 따라 우선적으로 감별해야 하지만, 소화기 질환 뿐만 아니라 반드시 **비뇨생식계 질환, 순환, 호흡기 증상과 여성의 경우 산과적 질환도 감별**해야 합니다.

비뇨생식계가 의심될 경우에는 CVA tenderness 신체 검진과 산과적 질환 의심 시 산과 문진을 잊지 말아야 합니다.

황달의 경우 감별해야 하는 요인과 신체 진찰이 많아 시간이 부족할 수 있어 주의해야 합니다.

간혹 문진 전부터 진통제를 요구할 수 있는데, 이때는 당황하지 말고 **진통제를 먼저 투여 시 정확한 진단이 어려울 수 있음을 설명하고 진찰 또는 진단을 내린 후 진통제를 드려**겠다고 단호히 되차분한 어조로 설명해야 합니다. 또한 응급 조치 및 수술이 필요한 경우, 환자 교육 파트에서 수술의 필요성을 잘 설명할 수 있어야 합니다.

마지막으로 **복부 신체 진찰 시** 복부에 힘이 들어가지 않도록 **다리를 굽히는 것**을 잊지 말아야 합니다.

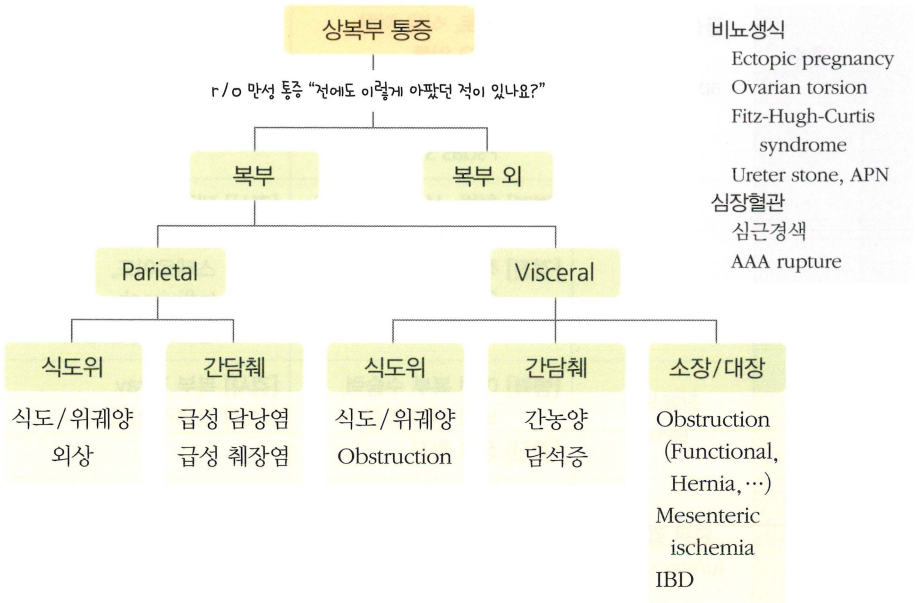
질병별 진단 / 치료 계획 정리

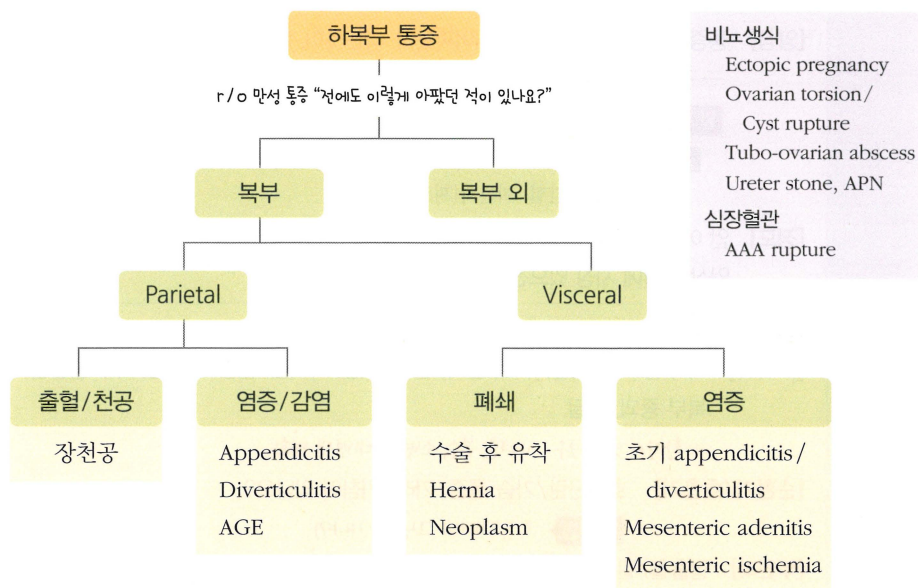
계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
상복부	위/십이지장	위염 (gastritis) / 위궤양 (gastric ulcer)	[병력] 식후 심해지는 통증, 명치 부분이 아픔, 메스꺼움, 구토, 속쓰림, 흑색변(궤양) [검진] 복부 압통	[검사] 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, <i>H. pylori</i> (위나 선균) 제균 치료, 위점막보호제
		소화 천공 궤양★ (peptic ulcer perforation)	[병력] 위궤양 증상 + 두근거림/어지럼 [검진] 전반적 복부 압통/ 반발 압통	[검사] 흉부 X-ray, 복부 CT [치료] 응급 개복 수술
		십이지장궤양 (duodenal ulcer)	[병력] 위염과 비슷한데 공복 시 통증 [검진] 복부 압통	[검사] 위내시경 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제 등 위염과 동일

상 복 부	췌장	급성 췌장염★ (acute pancreatitis)	[병력] 전날 과음 후 극심한 찌르는 듯한 통증 발생, 몸을 앞으로 굽히면 나아짐, 음식 섭취 후 악화, 구역, 구토 [검진] 극심한 복부 압통	[검사] 혈중 amylase, Lipase, 복부 CT [치료] 전해질 교정 및 수분 공급, 진통제(morphine), 코위관 삽입
	담도계	급성 담낭염★ (acute cholecystitis) /담석증(cholelithiasis)★ /담관염(cholangitis)★	[병력] RUQ pain, 황달(담관 염), 발열, 간헐적 통증 [검진] RUQ 압통 + Murphy's sign	[검사] 복부 CT, 복부초음파, 간기능검사 [치료] 담낭절제술, 항생제
	간	급성 간염 (acute hepatitis)	[병력] 황달, 우측골라 불쾌함, 메스꺼움, 피로, 관절통, 근육통 [검진] 간비대	[검사] 복부초음파, 간기능검사 [치료] 황달 부분 참조
	대동맥	복부 대동맥류 파열	[병력] 호흡곤란/ 극심한 찢어지는 통증 [검진] 복부의 박동성 종괴	[검사] 복부 CT [치료] 응급개복수술
	충수	급성 충수염★ (acute appendicitis)	[병력] 명치 부분에서 RLQ로 옮겨가는 통증, 구역, 구토, 식욕 저하 [검진] RLQ 압통, Rovsing's sign, Obturator sign, Psoas sign	[검사] 복부초음파, 복부 CT [치료] 충수절제술, 항생제
하 복 부	장	크론병 (crohn disease)	[병력] 혈변, 설사, 체중 감소, 항문 통증 [검진] 직장수지검사에서 혈변	[검사] 대장내시경 [치료] 설파살라진, 스테로이드, Infliximab, 충분한 영양 공급
		장폐색증 (ileus)	[병력] 이전 복부 수술력, 배꼽 주위 통증 [검진] 장음 항진	[검사] 복부 X-ray [치료] 코위관 삽입
	비뇨 기계	요관 결석★ (ureter stone)	[병력] 옆구리 통증, 배뇨통, 혈뇨, 간헐적 [검진] CVAT	[검사] 소변검사, KUB, 골반 CT [치료] 수액 치료, 초음파쇄석술, 수술

하 복 부	비뇨 기계	급성 신우신염 (acute pyelonephritis)	[병력] 혈뇨, 발열, 옆구리 통증 [검진] CVAT	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] 항생제
	여성	자궁 외 임신 (ectopic pregnancy)	[병력] 젊은 여성, 임신 가능성, 생리 주기 변화(무월경) [검진] 골반 진찰	[검사] 골반초음파검사, urine hCG [치료] 메토크레이트, 복강경술
		난소 꼬임 (ovarian torsion)	[병력] 여성, 구토, 극심한 통증 [검진] 골반 진찰	[검사] 질경유초음파(TVUS) [치료] 복강경술
		골반염증 질환 (PID)	[병력] 발열, 질분비물, 산부인과 수술 [검진] 골반 진찰	[검사] 소변검사, 복부 CT, 질분비물 배양, CBC [치료] 항생제(ceftriaxone)

증례별 알고리즘





기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 배가 아프기 시작했나요? [갑작] 갑자기 or 서서히 아프기 시작하셨나요? [상황] 어떤 상황에서 아프기 시작했는지? → 생리, 음식 섭취, 성관계, 불안/스트레스
L	어느 곳이 아프신가요? [이동] 아픈 부위가 이동하나요? [Referred pain] 다른 부위에 통증은 없나요?/통증이 어디로 퍼지나요?
D	[지속 시간] 복통이 얼마나 지속되나요? [빈도] (며칠 지속되었을 경우) 하루에 얼마나 자주 아프세요? [주기] 통증이 규칙적으로 있나요?
Co	통증이 점점 심해지나요?
Ex	이전에도 복통이 있었던 적이 있었나요?

C	[양상] 통증의 양상은 어떤가요? (쥐어짜듯이, 타는듯이, 베이듯이 등) → 구체적으로 말씀해 주시겠어요? 암기법 강도가 불타는 칼을 쥐어 계속 찌른다. 설명 강도(통증의 강도)가 불타는(타는 듯한) 칼을 쥐어(쥐어짜듯, 조이듯) 계속 (지속 or 간헐) 찌른다(찌르는 듯). [정도] 안 아플 때 0점, 가장 아플 때를 10점이라 하면 어느 정도인가요? 일상 생활에 지장 있으신가요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화/식은땀 [소화기] 식욕 감소/구역질/구토/변비/설사/토혈/흑색변/혈변/지방변/복부 팽만감/ 복부 종괴/황달 ☞ 황달이 있는 경우 : 가려움, 복수, 소변색/대변색 변화 [순환기/호흡기] 호흡곤란/가슴 통증/가래/기침이 있나요? 암기법 호통치더니 그냥 가거나? [부인과] 질출혈/질분비물(양의 변화, 색의 변화, 냄새 변화) [비뇨기] 거품뇨/빈뇨/혈뇨/배뇨통/소변색 변화 암기법 거 빈혈 있다더니 통 안색이 안 좋네 설명 거(거품뇨) 빈혈(빈뇨, 혈뇨)있다더니 통(배뇨통) 안색(소변색 변화)이 안 좋네
F	[식사] 식사 후 통증이 심해지나요?/공복 시 통증이 심해지나요? [음주] 음주 후 통증이 심해지나요? [자세] 자세에 따라서 통증이 변화하나요? (취장염 → 앞으로 숙이면 나아지나요?) [배뇨/배변] 배뇨/배변 등에 의해 통증이 변화하나요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 이상 소견 있으셨나요? 언제였나요?
외	[수술] 이전에 복부 수술을 받으신 적 있나요? [외상] 복부를 다친 적이 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? 고혈압/당뇨/고지혈증 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (복부 대동맥류 파열 → 고혈압 시 약 복용은 잘 했는지) ☞ 만약 환자가 없다고 할 경우 구체적인 약물 복용을 확인해야 하는데, 진통소염제(NSAID)와 제산제 복용 여부를 구체적으로 물어야 합니다.

사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [스트레스] 스트레스를 많이 받으시는 편인가요? [식습관, 운동] 최근 드신 음식 중 복통의 원인이 될 만한 것이 있을까요? 평소 기름진 음식을 많이 드세요? 규칙적으로 식사 하시나요?  최근 해산물 복용 여부도 확인합니다.
가	가족 중에 소화기 질환/암을 앓으신 분이 있나요?
여	[산과] 유산하시거나 분만하신 적이 있나요? [월경] 월경은 규칙적으로 하시나요?/생리 주기는 얼마인가요?/월경량은 적당한가요?/월경통은 심하신가요? [성관계] 이걸 누구에게나 하는 질문이니 당황하지 마시고요. 최근 성관계 경험이 있으신가요?/임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 혀(탈수), 출혈(구강 진찰 → 설암자) + 순환기/호흡기 의심 시 [목적 설명] 윗배가 아프신 분들 중 사실은 가슴이 아픈데 배가 아픈 것처럼 느낄 수 있습니다. → 심장 청진, 폐 청진 3. CVAT★ 뒤로 돌아주세요. 반드시 양쪽 다 확인, 양쪽을 한 번씩만 치는 것이 아니라 연속적으로 위에서 내려가며 여러 번 쳐준다. 4. 피부 : 손등 피부 긴장도, 하지 부종(pitting edema) [누워서] 5. 복부★ [시진] 아픈 부위를 가리켜 보세요. 기침해 보세요. (기침 시 통증, 팽만, 수술 흔적 확인) [청진] 차가우실 수 있어요(5구역, 3초씩). [타진] (아픈 부위 반대편부터 시작) 4군데, 한 군데당 2번씩 + 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진/복수(shifting dullness) [촉진] (아픈 부위 마지막) Superficial 4군데, Deep 4군데 통증 있으면 반동압통 확인 + 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간 촉진, 비장 촉진

[특이검사*] Upper : murphy, courvoisier(무통성 담낭이 만져짐)
Lower : psoas, obturator

☞ 시간이 없을 경우 murphy sign만 우선적으로 하지만, appendicitis 의심 시 psoas, rovsing, obturator sign을 하도록 합니다.

6. DRE : 직장수지검사

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

- ⊕ 많이 아파했을 경우 : 자세히 보고 정확히 진찰하려다 보니 신체 검진에서 불편을 드린 것 같습니다.

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 배가 아파서 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ○○○로 미루어 보아 A질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 상(하)복부 통증은 다양한 원인에 의해 유발될 수 있어서 그 외에 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 복부 X-ray와 CT, 위내시경검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 A질환이 확진되면 치료를 위해 금식 or 약물 치료 or 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다
교육	수술이 필요할지 모르니 지금부터 금식하셔야 합니다. 약을 규칙적으로 복용하고, 생활 습관을 교정하는 것이 치료에 가장 중요합니다. 술·담배는 A질환을 악화시킬 수 있기 때문에 반드시 끊어야 합니다. 또한 규칙적으로 식사를 하고 기름진 음식을 줄이는 것만으로도 A질환이 잘 조절될 수 있습니다. 배가 더 아프거나 다른 증상이 발생할 경우 언제든지 내원하세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

☞ 환자가 만약 진통제를 요구한다면, 진통제에 의해 정확한 진료가 어려울 수 있으므로 원인을 찾은 후 진통제 드리겠다고 양해를 구합니다.

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT, amylase/lipase, 전해질검사, 소변 hCG, ESR, CRP, 분비물 배양
- ② 영상검사 : 복부 초음파검사, 복부 X-ray(erect, supine)
- ③ GERD, peptic ulcer : 위내시경
- ④ 요로 결석 : KUB, 소변검사

❖ 치료 계획

- ① Ectopic preg. : laparoscopic salpingectomy, Methotrexate
- ② 요석 : 기대요법, 체외충격파쇄석술(ESWL, Extracorporeal shock wave lithotripsy)
- ③ PID : 3세대 cepha + doxycycline
- ④ 수술 : 소화 천공 궤양, 급성 담낭염, 복부 대동맥류 파열, 급성 충수염, 요관 결석, 자궁 외 임신, 난소 꼬임 등

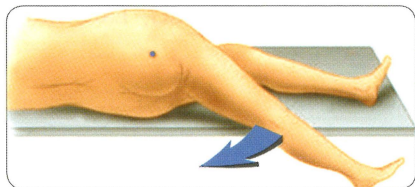
❖ 환자 안내/생활 습관 교육★

- ① 정확한 진단/치료 위해 입원이 필요할 수 있음을 설명
- ② 원인에 따른 치료 원칙 설명(특히 수술하는 경우 잘 설명)
- ③ 가임기 여성의 경우 급성 복통의 원인이 소화기계 또는 생식기계 등으로 다양할 수 있음을 설명하고 응급 상황인 경우 수술이 필요함을 교육함
- ④ 흡연은 자궁 외 임신의 위험 인자로 금연 교육이 필요, 골반 내 감염도 자궁 외 임신율을 높이므로 안전한 성관계 가질 것을 교육해야 함
- ⑤ 자궁 외 임신의 가장 흔한 합병증으로 지속적 자궁 외 임신이 가능하므로 복부 통증, 무월경, 질출혈 지속 시 다시 내원할 것 교육
- ⑥ 급성 췌장염 : 금식, 수액, NG tube(ileus 있으면), 진통제(morphine 계열)



keyword

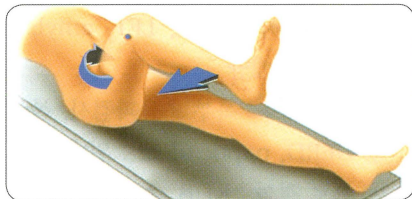
비노 생식계/순환 호흡계/여성의 경우 산과 질환 감별 진단하기
진통제는 진찰/진단 후 처방 가능성을 알리기
복부 진찰 시 항상 다리를 굽혀달라고 먼저 요청하기
응급 조치 및 수술이 필요한 경우 교육 파트에서 필요성 잘 설명하기
수술이 필요한 경우 금식도 교육하기



[Psoas 징후]

오른쪽 허벅지를 펴(신전)할 때 통증이 있음
(충수돌기가 후복막에 위치한 경우)

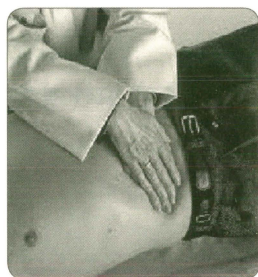
→ 급성 충수돌기염



[Obturator 징후]

오른쪽 허벅지를 안쪽 돌림(내회전)시킬 때
통증이 있음(충수돌기가 골반쪽에 있을 때)

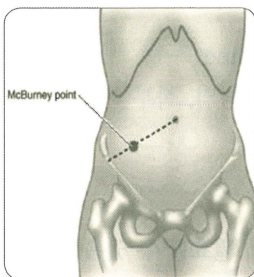
→ 급성 충수돌기염



[Rovsing 징후]

왼쪽 아랫배를 촉진했을 때
오른쪽 아랫배에 통증이 발생

→ 급성 충수돌기염



[McBurney 징후]

오른쪽 아랫배(ASIS와 배꼽의
중간)의 통증

→ 급성 충수돌기염



[Murphy 징후]

오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 경계 부위를
가볍게 누른 상태에서 숨을 깊게 들이
마시면 갑자기 통증이 유발

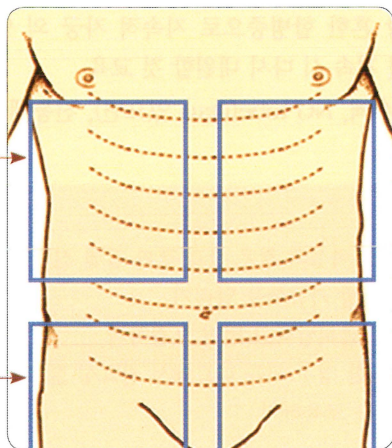
→ 급성 담낭염

우상복부 통증

- 간, 담도계 질환
- 췌장염
- 폐렴

우하복부 통증

- 충수돌기염
- 장폐쇄
- 개실염
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석



좌상복부 통증

- 위염, 위궤양
- 췌장염
- 비장 질환
- 심근경색, 폐렴

좌하복부 통증

- 개실염
- 장폐쇄(대장)
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석